

OSSUM COR — Roadmap de producto y visión de futuro

Versión: Julio 2026

Audiencia: empresas del rubro quirúrgico, ortopedias, distribuidoras, equipos operativos, socios y colaboradores.

Un sistema pensado para operar cirugías, materiales, documentación, facturación y cobros desde un expediente único, trazable e inteligente.

Cada cirugía debe tener un expediente único, vivo y trazable.

1. Idea central: un sistema pensado para empresas del rubro

OSSUM COR nace para empresas que operan alrededor de cirugías, materiales médicos, autorizaciones, remitos, consumos, devoluciones, documentación, facturación y cobros.

No es un sistema genérico. Está pensado para empresas que hoy trabajan con información repartida entre WhatsApp, planillas, papeles, correos, fotos, PDFs, sistemas parciales y conocimiento informal de cada área.

OSSUM COR apunta a convertirse en el centro operativo de la empresa: el lugar donde se conectan coordinación, logística, depósito, administración, facturación, cobranzas, documentación y dirección.

2. La promesa del producto

La promesa de OSSUM COR es que cualquier persona autorizada pueda entender el estado real de una cirugía sin perseguir mensajes, planillas o papeles.

Pregunta	Respuesta que debe dar OSSUM COR
¿Qué cirugía estamos operando?	Expediente único con paciente, médico, institución, cliente y estado.
¿Qué se autorizó o presupuestó?	Material, autorización, presupuesto y versiones.
¿Qué salió del depósito?	Remito conectado a la cirugía.
¿Qué se usó realmente?	Consumo registrado contra el caso.
¿Qué volvió?	Devolución clara y trazable.
¿Qué diferencia hubo?	Comparativa entre presupuestado, remitido, consumido y devuelto.
¿Se puede facturar?	Documentación, consumo, reglas y pendientes visibles.
¿Se cobró?	Factura, cobros, imputaciones y saldo.
¿Quién hizo cada acción?	Historial y auditoría.

Operar mejor, facturar mejor, cobrar mejor y decidir con más información.

3. Cómo contar el estado actual

Para explicar el avance sin tecnicismos, conviene dividirlo en tres niveles.

Nivel 1 — Ya es operativo
Cirugías, Expediente / Ficha CX, Contactos, Seguimiento, Notificaciones, Recibos Digitales, IA de autorizaciones, Remitos, Consumos, Devoluciones y Trazabilidad inicial.

Nivel 2 — Ya está diseñado o iniciado
Presupuestos, Preparación, Documentación quirúrgica completa, Facturación, Cobros, Coordinadores, Calendario, Tableros, Mail, Stock y Compras.

Nivel 3 — Falta cerrar el flujo completo
Conectar presupuesto, preparación, remito, consumo, devolución, comparativa, documentación, facturación, cobro, stock y reposición.

Lectura simple
Ya tenemos el centro de la operación armado. Ahora hay que terminar de conectar todos los módulos alrededor de la Ficha CX.

Presupuesto → Preparación → Remito → Consumo → Devolución → Comparativa → Documentación → Facturación → Cobro → Stock / trazabilidad / reposición

4. Dónde estamos parados hoy

OSSUM COR ya tiene un eje central claro: **Cirugía / Expediente / Ficha CX**. Ese eje permite ordenar el resto del producto.

Área	Estado actual explicado simple
Cirugías	Es el punto de partida del sistema. Cada caso quirúrgico tiene identidad propia.
Expediente / Ficha CX	Es la vista central donde se reúne la información del caso.
Contactos	Permite reutilizar pacientes, médicos, instituciones, clientes y otros actores.
Seguimiento / Novedades	Registra lo que pasa durante la vida del caso.
Notificaciones	Ayuda a coordinar acciones y pendientes del equipo.
Recibos digitales	Permite generar evidencia firmada digitalmente.
Correo / Mail	Empieza a vincular conversaciones y evidencia al expediente.
IA de autorizaciones	Ayuda a leer documentos y precargar datos.
Remitos	Conecta la cirugía con el material que sale.
Consumos	Registra lo que se usó realmente.
Devoluciones	Registra lo que vuelve después de la cirugía.
Trazabilidad	Reconstruye eventos y movimientos del caso.

Punto clave: OSSUM COR ya no debe pensarse como pantallas separadas, sino como un expediente central al que se conectan módulos operativos.

5. Qué apartados ya creamos, trabajamos o diseñamos

Bloque	Apartados incluidos
Núcleo quirúrgico	Cirugías, Expediente / Ficha CX, Wizard de Nueva Cirugía, tabla operativa, estados y preferencias de vista.
Operación del expediente	Cabecera, pestañas, seguimiento, historial, macro timeline, referencias, logística, documentación, remitos, consumo, devolución y trazabilidad.
Movimiento de material	Remitos, Consumos, Devoluciones, Trazabilidad inicial y base para stock/cajas/lotos/series/vencimientos.
Comunicación y coordinación	Notificaciones internas, menciones, mail asociado a cirugía, bandeja de coordinación y compartir cirugía por WhatsApp.
Documentos y evidencia	Recibos digitales, firma pública, evidencia desde correo, IA para autorizaciones y base documental futura.
Comercial y financiero	Presupuestos diseñados, facturación/cobros trabajados como lógica previa y diseño pendiente del flujo definitivo.
Gestión transversal	Contactos, Coordinadores, Calendario, Tableros y Compras/Proveedores como etapa posterior.

6. Roadmap por fases claras

Fase 1 — Consolidar Cirugía / Expediente / Ficha CX avanzado

Objetivo: que cada cirugía sea una ficha única, clara y confiable.

Valor: una sola vista para entender el caso, coordinar áreas y conectar todos los módulos.

Fase 2 — Cerrar Remito → Consumo → Devolución → Trazabilidad en consolidación

Objetivo: saber qué material salió, qué se usó, qué volvió y qué diferencia quedó.

Valor: control real del material quirúrgico y base para stock, comparativa y facturación.

Fase 3 — Presupuesto y preparación diseñado/iniciado

Objetivo: conectar lo estimado, autorizado o presupuestado con lo que se prepara y entrega.

Valor: mejor planificación del material y menos diferencias operativas.

Fase 4 — Comparativa operativa pendiente

Objetivo: comparar presupuesto, remito, consumo y devolución.

Valor: detectar diferencias antes de facturar o reclamar.

Fase 5 — Documentación quirúrgica completa parcial

Objetivo: saber qué documentación existe, qué falta y qué bloquea cierre/facturación.

Valor: menos casos trabados por papeles faltantes.

Fase 6 — Facturación y cobros pendiente

Objetivo: registrar qué se factura, contra qué base, cuánto se cobra y qué queda pendiente.

Valor: mejor control económico por cirugía, cliente y empresa.

Fase 7 — Stock, cajas y compras posterior**Objetivo:** saber dónde está cada material, qué se movió, qué se usó y qué hay que reponer.**Valor:** menos faltantes, menos pérdidas y mejor planificación de compras.**Fase 8 — Seguridad, permisos y auditoría** clave**Objetivo:** que cada usuario vea y haga solo lo que corresponde, y que cada acción importante deje huella.**Valor:** confianza empresarial, control multiempresa y menor riesgo operativo.**Fase 9 — IA e integraciones externas** funcional parcial**Objetivo:** reducir carga manual, convertir documentos en datos útiles e integrar servicios externos.**Valor:** más velocidad operativa sin perder control del expediente.

7. Visión futura: OSSUM COR como tablero inteligente

La visión futura es que OSSUM COR evolucione de ERP operativo a plataforma inteligente de gestión quirúrgica. El sistema no solo registra información: ayuda a decidir.

El tablero debe mostrar

cirugías listas para operar, material pendiente, remitos sin consumo, diferencias, devoluciones faltantes, documentación que bloquea facturación y casos urgentes.

La inteligencia debe anticipar

qué se puede facturar, qué falta reclamar, qué stock reponer, qué clientes concentran deuda y qué documentos puede leer o clasificar la IA.

OSSUM COR debe centralizar, conectar, alertar, aprender y ayudar a decidir.

8. Cierre ejecutivo

OSSUM COR ya tiene su eje principal: **Cirugía / Expediente / Ficha CX**. Sobre ese eje ya se trabajaron apartados fundamentales: Contactos, Seguimiento, Notificaciones, Recibos Digitales, Correo, IA de Autorizaciones, Remitos, Consumos, Devoluciones y Trazabilidad inicial.

El siguiente paso es cerrar el circuito completo alrededor de la cirugía:

Presupuesto → Preparación → Remito → Consumo → Devolución → Comparativa → Documentación → Facturación → Cobro → Stock / compras

Todo módulo nuevo debe conectarse al expediente. Todo dato importante debe cargarse una vez y reutilizarse. Toda acción crítica debe poder rastrearse.

Documento público. No reemplaza especificaciones técnicas, ADRs ni aprobaciones formales para cambios críticos.